

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO DE SCREENING DE ANSIEDAD (ASQ-15)

Anxiety Screening Questionnaire (Wittchen & Boyer, 1998) · Max Planck Institute of Psychiatry

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario de Screening de Ansiedad de Wittchen (Anxiety Screening Questionnaire, ASQ-15)
Sigla / Acrónimo	ASQ-15
Autoría original	Hans-Ulrich Wittchen & Patrice Boyer (Max Planck Institute of Psychiatry, Múnich, 1998)
Procedencia nosológica	Derivado del M-CIDI (Munich Composite International Diagnostic Interview) de la OMS
Constructo evaluado	Cribado sistemático del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y otros 5 síndromes de ansiedad DSM-IV/5
Población diana	Adultos atendidos en atención primaria, urgencias médicas, consultas de cardiología o salud mental
Tiempo de aplicación	3 a 5 minutos (autoadministrado o administrado en el triaje de enfermería)
Estructura y formato	15 ítems dicotómicos (Sí / No) organizados en motivo de consulta, diagnósticos y síntomas asociados
Condiciones de uso	Uso libre para fines clínicos y docentes no comerciales citando al Instituto Max Planck

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Los trastornos de ansiedad representan la patología psiquiátrica más prevalente en la población general y en atención primaria, con una prevalencia-vida superior al 25%. No obstante, el Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) se infradiagnostica de forma masiva: más del 60% de los pacientes con TAG acuden al médico consultando exclusivamente por síntomas somáticos polimorfos (cefaleas tensionales, dispepsia funcional, contracturas cervicales, insomnio de conciliación o palpitaciones), sin verbalizar espontáneamente su angustia psicológica.

Para resolver este infradiagnóstico, Wittchen y Boyer diseñaron el ASQ-15 como un instrumento de cribado ultrarrápido derivado de la entrevista estandarizada M-CIDI. Su marco conceptual combina una evaluación rápida de la preocupación crónica excesiva e incontrolable (durante al menos 6 meses) con preguntas de despistaje dirigidas a otros cinco cuadros ansiosos comórbidos: Trastorno de Pánico, Agorafobia, Fobia Social, Trastorno Obsesivo-Compulsivo y Fobias Específicas.

3. ESTRUCTURA DE LAS TRES SECCIONES DEL ASQ-15

Sección	Ítems Origen	Respuesta	Objetivo Diagnóstico y Cuadros Evaluados
1. Motivo de Consulta	Ítem 1	Sí / No	Determina si la visita médica actual está motivada primariamente por problemas de ansiedad, nervios o estrés
2. Despistaje Sindrómico	Ítems 2 a 7	Sí / No	Cribado diferencial de: Pánico (2), Agorafobia (3), Fobia Social (4), Fobias Específicas (5), Ansiedad Generalizada (6) y TOC (7)
3. Criterios de TAG	Ítems 8 a 15	Sí / No	Cronicidad $\geq$ 6 meses (8), falta de control (9) y síntomas somáticos cardinales: inquietud/tensión (10), fatiga (11), concentración (12), irritabilidad (13), tensión muscular (14) y sueño (15)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Sensibilidad para TAG	Sensibilidad del 87 — 92% frente al diagnóstico estructurado M-CIDI para Trastorno de Ansiedad Generalizada.
Especificidad diagnóstica	Especificidad del 84 — 88% en pacientes de atención primaria y consultas ambulatorias médicas.
Valor predictivo positivo	VPP del 78% en poblaciones asistenciales con alta sospecha de somatización o multiconsulta.
Valor predictivo negativo	VPN del 94 — 96%; una puntuación negativa descarta de manera muy fiable la presencia de un TAG según DSM-IV/5.
Validez de constructo	Correlación positiva muy alta con la Escala de Ansiedad de Hamilton (HARS, $r = 0.76$) y con el inventario GAD-7 ($r = 0.81$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Regla diagnóstica de TAG	Para un cribado Positivo en TAG se requiere obligatoriamente: 1) Respuesta SÍ al Ítem 6 (preocupación excesiva); Y 2) Respuesta SÍ al Ítem 8 (duración ≥ 6 meses); Y 3) Respuesta SÍ al Ítem 9 (dificultad para controlar la preocupación); Y 4) Al menos 3 respuestas SÍ en los ítems somáticos del 10 al 15 .
Cribado de otros trastornos	Respuestas afirmativas a los ítems 2, 3, 4, 5 o 7 indican sospecha clínica de Pánico, Agorafobia, Fobia Social, Fobia Específica o TOC, requiriendo módulos específicos.
Puntuación continua opcional	Suma directa de los ítems de síntomas del TAG (ítems 8 a 15, rango 0 a 8 puntos).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Criterio ASQ-15	Frecuencia	Clasificación	Significación y Conducta Recomendada
No cumple criterios	70 - 75%	Screening Negativo	Sin sospecha de TAG o trastorno de ansiedad mayor estructurado.
Cumple cribado TAG	15 - 20%	Cribado Positivo para TAG	Alta probabilidad de TAG formal; confirmación clínica y tratamiento.
Síntomas en 2 a 5 o 7	10 - 15%	Ansiedad Comórbida	Identifica comorbilidad ansiosa compleja (pánico, fobia social, TOC).

PUNTO DE CORTE CANÓNICO (WITTCHEN & BOYER):

- **Cumplimiento de Criterios Completos de TAG (Ítems 6 + 8 + 9 + 3 de los ítems 10-15):** Confirmación diagnóstica con una sensibilidad del 89% frente a entrevista estructurada CIDI. Prohíbe despachar al paciente con tranquilizantes aislados a demanda; exige un plan de intervención psicoterapéutica y/o farmacológica pautada.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS

Paso 1: Aplicación del ASQ-15: En pacientes con quejas somáticas vagas o hiperfrecuentación.

Paso 2: Si el Cribado de TAG es Positivo:

- Descartar causa médica orgánica o farmacológica (hipertiroidismo, consumo de cafeína excesivo, broncodilatadores beta-agonistas).
- Tratamiento de primera línea: Psicoterapia Cognitivo-Conductual (reestructuración de la intolerancia a la incertidumbre y desensibilización al control de preocupaciones).
- Farmacoterapia de primera línea si es necesario: ISRS (escitalopram, sertralina) o IRSN (venlafaxina, duloxetina). Evitar pautas prolongadas de benzodiacepinas.

Paso 3: Si Hay Positividad en Ítems 2 (Pánico) o 4 (Fobia Social): Profundizar en la anamnesis con la Escala de Pánico PDSS o de Fobia Social LSAS.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN MEDICINA DE FAMILIA

Identificación: Mujer de 35 años, dependiente de comercio, que acude a su centro de salud por contracturas cervicales continuas, cefaleas opresivas vespertinas y dificultades de concentración de casi 1 año de evolución.

Evaluación ASQ-15:

- Sección 1: Ítem 1 = No (consultaba por dolor físico, no por ansiedad).
- Sección 2: Ítem 6 = Sí ("Me preocupo constantemente por la salud de mis hijos, el dinero y cualquier imprevisto"). Ítems 2, 3, 4, 5, 7 = No.
- Sección 3: Ítem 8 = Sí (> 6 meses); Ítem 9 = Sí ("No puedo frenar los pensamientos catastrofistas"); Ítems somáticos: Inquietud (Sí), Fatiga fácil (Sí), Fallos de concentración (Sí), Tensión muscular (Sí), Insomnio de inicio (Sí) (**5 de 6 síntomas positivos**).

Diagnóstico: Cribado categórico **Positivo para Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG).**

Plan Terapéutico: Se evitó solicitar resonancia magnética cervical innecesaria; se explicó a la paciente el origen somatomuscular de su dolor por hipertonía ansiosa crónica. Se inició escitalopram 10 mg/día junto con pautas de relajación muscular progresiva de Jacobson.

Reevaluación a los 3 meses: Desaparición completa de las contracturas y cefaleas, con cese de las rumiaciones desadaptativas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Comorbilidad Oculta:

- **Depresión Mayor Subyacente:** El TAG prolongado no tratado desemboca en depresión secundaria grave en más del 60% de los casos; vigilar desesperanza.
- **Automedicación con Alcohol o Sedantes:** Alto riesgo de dependencia encubierta para "desconectar la mente".

Diagnóstico Diferencial:

- **Trastorno de Pánico vs. TAG:** En el pánico la ansiedad es paroxística e inesperada; en el TAG es continua, flotante y centrada en preocupaciones cotidianas.
- **Feocromocitoma o Arritmias:** Descartar patología orgánica adrenal o cardiovascular si hay paroxismos adrenérgicos intensos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Wittchen, H. U., & Boyer, P. (1998). Screening for anxiety disorders in primary care: The Anxiety Screening Questionnaire (ASQ-15). **Max Planck Institute of Psychiatry / World Health Organization**.
- Wittchen, H. U. (2002). Generalized anxiety disorder: prevalence, burden, and cost to society. **Depression and Anxiety**, 16(4), 162-171. <https://doi.org/10.1002/da.10065>
- Wittchen, H. U., Lachner, G., Wunderlich, U., & Pfister, H. (1998). Test-retest reliability of the computerized DSM-IV version of the Munich-Composite International Diagnostic Interview (M-CIDI). **Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology**, 33(11), 568-578.
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B., Monahan, P. O., & Löwe, B. (2007). Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. **Annals of Internal Medicine**, 146(5), 317-325.